VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 94–96
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.108887

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania paracetamolu w ciąży i ryzyka autyzmu u potomstwa

Statement of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on paracetamol use during pregnancy and autism risk

Maria Szubert[1, 2], Rafał Stojko[3], Piotr Sieroszewski[4]

[1]Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[2]Visiting Faculty at John Hopkins Medical Institute, Baltimore, USA
[3]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[4]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Szubert M, Stojko R, Sieroszewski P, „Statement of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on paracetamol use during pregnancy and autism risk", Ginekol Pol 2025; doi: 10.5603/gpl.108872. Należy cytować wersję pierwotną.

Niniejsze stanowisko jest odpowiedzią na poruszenie medialne wywołane wypowiedzią Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki — Donalda Trumpa, dotyczącą znaczącego podwyższania ryzyka autyzmu u dzieci urodzonych przez kobiety, które przyjmowały paracetamol w ciąży. Wypowiedź ta, nacechowana emocjonalnie: *„Don't take Tylenol. Don't take it (...) Fight like hell not to take it"* (tłum. „Nie bierz Tylenolu. Nie bierz go (...) Walcz z całych sił, żeby go nie brać") [1], może przemawiać do społeczeństwa, powodując negatywne skutki i narażając kobiety ciężarne na niepokój, zaburzenia depresyjne po porodzie bądź unikanie leczenia przeciwbólowego i przeciwgorączkowego, gdy jest ono niezbędne [2].

W odpowiedzi na wypowiedź Prezydenta Trumpa największe towarzystwa skupiające ginekologów i położników: Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa (FIGO, *International Federation of Gynecology and Obstetrics*), Europejska Rada i Kolegium Położnictwa i Ginekologii (EBCOG, *European Board and College of Obstetrics and Gynaecology*), Amerykański Dziennik Położnictwa i Ginekologii (AJOG, *American Journal of Obstetrics and Gynecology)* i Królewskie Kolegium Położników i Ginekologów (RCOG, *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*) wypuściły stanowiska potwierdzające bezpieczeństwo stosowania paracetamolu w ciąży w uzasadnionych wskazaniach [3, 4]. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA, *Food and Drug Administration*) podjęła kroki dotyczące własnej oceny opublikowanych w ostatnim czasie wyników, pisząc, że dotychczas związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przyjmowaniem paracetamolu w ciąży a autyzmem u potomstwa nie został udowodniony, a dane literaturowe są sprzeczne [5]. Do czasu ich uzyskania stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) pozostaje zgodne ze stanowiskami wyżej wymienionych towarzystw. Przesłanki do jego podtrzymania są aktualnie następujące:

1. *The Swedish Population Study*, JAMA 2024 — badanie o wysokiej jakości danych, w którym jako grupę kontrolną wykorzystano rodzeństwo dzieci chorych na autyzm (w celu wykluczenia wpływu czynników genetyczno-środowiskowych), nie wykazało wpływu przyjmowania paracetamolu w ciąży na zwiększenie częstości autyzmu u dzieci (HR 0.98, 95% CI: 0.94–1.02), ani zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, *attention-deficit/hyperactivity disorder*) (HR 0.98, 95% CI: 0.95–1.01) [6].
2. Badanie populacji japońskiej wykazało ryzyko na poziomie HR 1,08 dla ogólnej grupy zaburzeń

Adres do korespondencji: Maria Szubert, *Visiting Faculty at John Hopkins Medical Institute*, *Baltimore*, USA
e-mail: maja.szubert@gmail.com

neurorozwojowych oraz HR 1,06 dla autyzmu; jednak po wprowadzeniu grupy kontrolnej wartość HR spadła do 0,68. Autorzy badania wnioskują, że czynniki, takie jak błędna klasyfikacja, niewłaściwy dobór grup badanych czy nieuwzględnienie innych czynników środowiskowych, mogą w badaniach populacyjnych prowadzić do przypadkowego zawyżenia ryzyka, które następnie bywa błędnie interpretowane jako związek przyczynowo-skutkowy [7].

Należy nadmienić, że w literaturze znajdują się badania wskazujące na związek paracetamolu z autyzmem oraz że największą liczbę danych uzyskaliśmy w ostatnich 10 latach. Prawdopodobnym podłożem wypowiedzi Pana Prezydenta było badanie opublikowane w sierpniu 2025 roku przez zespół naukowców amerykańskich, które jest przeglądem piśmiennictwa — jakościową analizą wykorzystującą tzw. *navigation guide methodology* (skrupulatną i rygorystyczną metodykę prowadzenia przeglądu piśmiennictwa) [8]. Autorzy przeglądu w samokrytyce piszą, że nie są w stanie ustalić związku przyczynowo-skutkowego ani podać dawki, która mogłaby wpływać na podwyższanie ryzyka. Przegląd ten został skrytykowany przez innych badaczy za niedociągnięcia metodologiczne, między innymi za włączenie w analizę prac o niskiej jakości danych, podczas gdy jednym z kryteriów wyłączenia była „jakość prowadzonych badań".

Poszukując ewentualnego związku dawki z zaburzeniami ze spektrum, warto wgłębić się w jedną z ostatnich prac z populacji amerykańskiej, tak zwanego badania IKIS (*Illinois Kids Development Study* — badanie prospektywne na temat wpływu różnych czynników środowiskowych i toksyn w okresie prenatalnym na neurorozwój pourodzeniowy). W suplemencie (!) autorzy podają średnie dawki paracetamolu przyjmowane przez matki w ciąży oraz przyczyny przyjmowania. Mediany dawek to około 30–50 tabletek na ciążę, a odchylenia dochodzą do setek tabletek przy około 100 różnych przyczynach raportowanych przez kobiety, od bólu zęba, przez przeziębienie, po uzależnienia i nowotwory. Autorzy zwracają uwagę, iż słabością badania może być brak przeprowadzenia korekty wielokrotnych porównań (tłumacząc prościej — wykonując kilkaset zestawień bez takiej korekty, badacz znajdzie praktycznie na pewno bardzo wiele przypadkowo istotnych statystycznie różnic) [9]. Nie mamy badań z populacji polskiej dotyczącej liczby przyjmowanych tabletek paracetamolu w ciąży, niemniej powyższe dawki wydają się ogromne.

Podsumowując, należy na chwilę obecną podtrzymać rekomendację dla paracetamolu jako leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego stosowanego jako lek z wyboru u kobiet ciężarnych. Warunkiem stosowania pozostaje jak najmniejsza skuteczna dawka, przez jak najkrótszy czas.

Komentarz autorów

Analizując wypowiedź Pana Prezydenta Donalda Trumpa, rynek amerykański oraz ostatnie badania i publikacje z USA, należy mieć na uwadze kilka kwestii:

1. Popularny Tylenol (nazwa handlowa przywołana przez Prezydenta) oraz inne preparaty paracetamolu są dostępne w sprzedaży bez recepty (OTC) w sieciach handlowych, w opakowaniach zawierających nawet do 1000 tabletek (dwupak), w dawkach od 325 mg na tabletkę (Tylenol) do 500–600 mg w przypadku innych preparatów paracetamolu.
2. Dziekan Harvardu, który firmował ostatnią publikację z 2025 roku, w sekcji „*disclosure statement*" ujawnia, że był wynagradzany jako biegły w sprawach sądowych wytaczanych rodzinom przeciwko firmie produkującej paracetamol.
3. Znane chyba na całym świecie nieprawidłowości związane z legalizowaniem i korumpowaniem wysoko postawionych urzędników i profesorów przez firmy farmaceutyczne w USA, dotyczące leków przeciwbólowych (oksykodon jako lek na każdy ból!) powodują, że temat leków rozgrzewa i polaryzuje społeczeństwo w USA.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie

Autorzy zgłaszają brak finansowania.

Konflikt interesów

Autorzy zgłaszają brak konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Trump Uses Harvard Public Health School Dean's Research to Link Tylenol to Autism. https://www.thecrimson.com/article/2025/9/23/autism-tylenol-study-trump/ (24.09.2025).
2. Motyka R, Sioma-Markowska U. Postpartum emotional disorders — a narrative review. Ginekol Pol. 2025; 96(7): 607–612, doi: 10.5603/gpl.104124, indexed in Pubmed: 40145696.
3. Paracetamol (acetaminophen) use during pregnancy and autism risk: evidence does not support causal association. https://www.figo.org/paracetamol-acetaminophen-use-during-pregnancy-and-autism-risk-evidence-does-not-support-causal (24.09.2025).
4. ACOG Affirms Safety and Benefits of Acetaminophen during Pregnancy. https://www.acog.org/news/news-releases/2025/09/acog-affirms-safety-benefits-acetaminophen-pregnancy (24.09.2025).
5. FDA Responds to Evidence of Possible Association Between Autism and Acetaminophen Use During Pregnancy. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-responds-evidence-possible-association-between-autism-and-acetaminophen-use-during-pregnancy (24.09.2025).

6. Ahlqvist VH, Sjöqvist H, Dalman C, et al. Acetaminophen Use During Pregnancy and Children's Risk of Autism, ADHD, and Intellectual Disability. JAMA. 2024; 331(14): 1205–1214, doi: 10.1001/jama.2024.3172, indexed in Pubmed: 38592388.
7. Okubo Y, Hayakawa I, Sugitate R, et al. Maternal Acetaminophen Use and Offspring's Neurodevelopmental Outcome: A Nationwide Birth Cohort Study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2025 [Epub ahead of print], doi: 10.1111/ppe.70071, indexed in Pubmed: 40898607.
8. Prada D, Ritz B, Bauer AZ, et al. Evaluation of the evidence on acetaminophen use and neurodevelopmental disorders using the Navigation Guide methodology. Environ Health. 2025; 24(1): 56, doi: 10.1186/s12940-025-01208-0, indexed in Pubmed: 40804730.
9. Woodbury ML, Geiger SD, Schantz SL. The relationship of prenatal acetaminophen exposure and attention-related behavior in early childhood. Neurotoxicol Teratol. 2024; 101: 107319, doi: 10.1016/j.ntt.2024.107319, indexed in Pubmed: 38199313.